

15/06/2025
י"ט/סיון/תשפ"ה

דגשים רפואיים 2 – מבצע "עם כלביא" - עקרונות הטיפול בפגיעות מעיכה

1. כל נפגע לכוד עלול לסבול מפגיעת מעיכה, אשר עלולה לגרום לתסמונת מעיכה (הפרקלמיה, היפוולמיה, אי ספיקת כליות).
2. יש לחשוד בהתפתחות של תסמונת מעיכה בכל נפגע אשר:
 - א. היה לכוד מעל 40 דקות עם לחץ ברור על פלג גוף תחתון (ישבן, גפיים תחתונות)/לחץ על הגו /לחץ על גפה עליונה רחבת היקף.
 - ב. נותן שתן כהה.
 - ג. שוכב ללא יכולת תנועה על משטח קשה מעל 40 דקות.
3. בגישה לפצוע לכוד או לאחר חילוץ יש לבצע סקר ע"פ A-B-C, לטפל בבעיות מסכנות חיים תוך שמירה על עמ"ש / עמ"צ ומיד אחר כך להתחיל בטיפול מאסיבי בהעמסת נוזלים.
4. יש לשאוף לפינוי דחוף של פצוע אשר היה לכוד.
5. במצבים של אסון המוני עלול להיווצר מצב בו לא ניתן לפנות פצוע עם חשד לפגיעת מעיכה, מצבים אלו יחייבו טיפול בהעמסת נוזלים וניטור קפדני.
6. ניתן לשלב טיפול בכאב בהתאם לפרוטוקול הטיפול בכאב במידת הצורך.
7. העמסת נוזלים:
 - א. העמסת נוזלים הנה הפעולה הראשונה והחשובה ביותר לפצוע עם חשד לפגיעת מעיכה לאחר הערכה וטיפול בסכנות A-B-C.
 - ב. בנפגע מבוגר יש לשאוף למתן של 1-2 ליטר סליין ו 20 מ"ל/ לשעה בילד בשעתיים הראשונות.
 - ג. לאחר שעתיים יש להמשיך במתן נוזלים במינון של 0.5 ליטר לשעה במבוגר ו 10 מ"ל/ק"ג/ לשעה.
 - ד. יש להביא בחשבון את תנאי הסביבה בהם נמצא הלכוד: חום = איבוד נוזלים מוגבר, קור = היפותרמיה במתן נוזלים.
 - ה. במידת האפשר יש לנטר תפוקת שתן כאשר השאיפה היא לכמות שתן של לפחות 50 cc/h במבוגר ובילדים 1-2 cc/kg/h.
 - ו. יש להעמיס נוזלים בצורה מבוקרת ולהקפיד על הגדלת או הפחתת כמות הנוזלים בהתאם למשקל המטופל, מצבו ותוך התחשבות באופן הנוזלים המשוער שלו:
 - אובדנים משוערים - נוזלים אותם איבד הלכוד עד חילוצו במסגרת זו יש להתחשב בטמפרטורת הסביבה, דימומים, שלשולים, הקאות, ופרק הזמן שחלף מתחילת האירוע עד תחילת מתן נוזלים. פרק זמן ארוך יחשיד להתייבשות, ויחייב פיצוי על האובדנים המשוערים.
 - משקל - לכודים גדולי גוף יצרכו כמות גדולה יותר של נוזלים.
 - מנח גוף - לכודים בתנוחה בה האגן והגפיים התחתונות גבוהים מהלב נמצאים בסיכון מוגבר לפתח בצקת ריאות.
8. תרופות (באישור מוקד רפואי):
 - א. גלוקוז: מתן גלוקוז לפצוע לכוד מאפשרת מתן פחמימות באופן מבוקר ומסייעת בפינוי אשלגן מהדם. למתן גלוקוז בריכוז 5% תופעות לוואי שוליות (מומלץ בחילוף ממושך – מעל 2 ש'). ניתן למהול 25 גרם גלוקוז ב 500 מ"ל סליין בכדי להשיג תמיסה של 5%.

- ב. **ביקרבונט:** יינתן רק למטופלים עם עדות לפגיעה בלייטית (מיוגלובינוריה) ו/או סימנים להיפרקלמיה שניתן לנטרם ברציפות. מתן תמיסה המכילה ביקרבונט מתקנת חמצת מטבולית, מצמצמת הצטברות של מיוגלובין וחומצה אורית בכליה ומסייעת לפינוי אשלגן מהדם. לביקרבונט תופעות לוואי משמעותיות ולכן יש לנטר את החולה באופן רציף לאחר מתן התרופה. אין לתת ביקרבונט לחולה שלא ניתן לנטרו.
- מינון - מתן חד פעמי של 50meq מהול ב – 1000מ"ל (או שתי מנות של 25meq מהול ב 500מ"ל סליין).
- ג. **פוסיד:** יינתן רק למטופל עם עדות לגודש ריאתי בעקבות מתן נזלים /למטופל עם סימני היפרקלמיה. אין לתת פוסיד לשם שיתון החולה בלבד, טיפול במשתני לולאה בחולים עם אי ספיקה בלייטית עלולה להחמיר את מצבם.
- מינון – מתן חד פעמי של 1מ"ג/ק"ג תוך ורידי /גרמי.
- ד. **ונטולין:** יינתן רק למטופלים עם עדות להיפרקלמיה / ברונוכספזם.
- מינון – 5 מ"ג + 2 מ"ל סליין באינהלציה.
- ה. **קלציום גלוקונט** – יינתן רק למטופלים עם עדות להיפרקלמיה באק"ג.
- מינון מבוגר – 1ג' (אמפולה אחת) של קלציום גלוקונט 10% במתן איטי (2-1דק')
- מינון ילדים – 60מ"ג/ק"ג עד למקס' של 1ג'.

פרוטוקול הטיפול בפגיעת מעיכה (ALS):

